SAHATI

Le soin, relié.

UNE PLATEFORME CONÇUE POUR RELIER LE SOIN

Le dossier suit le patient. Les équipes gardent le fil.

Une démonstration de parcours hospitaliers, patients et pédagogiques pour préparer un pilote volontaire en Algérie.

Le problème à traiter

Rendez-vous, consultations, prescriptions et résultats peuvent rester séparés. La qualité d’une plateforme se mesure à la continuité de l’information et aux tâches que chaque utilisateur accomplit.

Ce que montre la version 0.2

Un même scénario relie une arrivée à une consultation, à une ordonnance et à un résultat publié. Le patient retrouve ses documents et leurs passages sources. Les équipes disposent de files de travail et de statuts cohérents.

Solution privée indépendante. Aucun partenariat ministériel, aucune homologation et aucun bénéfice clinique ou économique acquis ne sont annoncés.

DES TÂCHES QUI PRODUISENT UN RÉSULTAT

Sept parcours à examiner.

Patient et consultation

Demande et modification d’un rendez-vous, confirmation d’arrivée, consultation reliée, validation et documents visibles dans le même coffre.

Ordonnance et laboratoire

Champs structurés, PDF A4, QR opaque local, prélèvement, résultats chiffrés, sources conservées et publication distincte de la validation.

Radiologie

Réservation d’équipement avec conflit ; vrai fichier DICOM de fantôme synthétique, fenêtre/niveau/zoom. Aucun PACS ou visualiseur clinique connecté.

Hospitalisation

Admission, lit, situation du patient et indicateurs évoluent ensemble. La sortie documentée conduit au bionettoyage du lit.

Campus médical

Trois cas fictifs, neuf questions, exploration, correction et progression personnelle. Contenus à faire revoir par des enseignants.

Recherche et direction

Accès personnel à une cohorte minimisée, descriptif et Kaplan-Meier ; cinq KPI définis, filtres territoriaux et rapports synthétiques.

Aucune donnée réelle. Les modifications restent sur un appareil ; les chiffres ne décrivent pas les hôpitaux algériens.

GOUVERNANCE ET LIMITES VISIBLES

Une base à faire valider.

Droits et information

Les rôles du moteur distinguent clinique, gestion, patient, formation et recherche. Les administrateurs et chercheurs n’accèdent pas automatiquement aux dossiers nominatifs. Les versions des mutations sont conservées.

Lecture fidèle des documents

Les explications sont déterministes et reliées aux champs sources. Valeurs, unités et consignes restent inchangées. Un intervalle absent est indiqué absent. Aucune IA autonome ne pose de diagnostic ou ne modifie une prescription.

La frontière du prototype

GitHub Pages ne fournit pas une infrastructure de soins. Le coffre local et ses permissions ne protègent pas contre le propriétaire du navigateur. Un QR nécessite le même coffre ; les PDF ne sont pas des signatures qualifiées.

Avant des données réelles : cadre juridique algérien, responsables, délégué, habilitations serveur, audit indépendant, hébergement, contrats, sauvegardes et restauration. Sources : lois 18-07 et 25-11, à instruire avec les juristes.

UN PILOTE LIMITÉ, MESURABLE ET PROGRESSIF

Commencer avec le terrain.

1. Observer et cadrer

Un établissement volontaire, un service de consultation et son laboratoire. Observer les tâches, définir une référence de comparaison et valider la gouvernance.

2. Construire la base pilote

API sécurisée, identité, séparation des établissements, données normalisées, documents revus, audit et reprise. Puis connecteurs laboratoire et OHIF/Orthanc selon les systèmes existants.

3. Évaluer avant d’étendre

Comparer temps et réussite des tâches, complétude, transmissions, compréhension patient, accessibilité et incidents. Prévoir un évaluateur indépendant et un retour au système précédent.

Moyens et coûts à chiffrer

Découverte, développement, validation clinique, sécurité, interfaces, migration, formation, hébergement et exploitation doivent être devisés séparément. Aucun tarif ferme ou retour sur investissement n’est établi.

Références publiques : Epic/MyChart, Oracle Health, MEDITECH, TrakCare, Dedalus, OpenMRS, OpenEMR, Bahmni, DHIS2, OMS, HL7 et DICOM. Détails et liens dans BENCHMARK.md.

Démonstration : https://achraf-saidi.github.io/sahati/
Documentation : github.com/Achraf-Saidi/Achraf-Saidi.github.io/tree/main/sahati